Prothèse de hanche ou de genou : diagnostic et prise en charge de l'infection dans le mois suivant l'implantation

Diapositives à partir des
recommandations pour la pratique clinique
HAS Mars 2014

Validation diapositives Groupe recommandation le 29/06/2016

Messages clés (1)

- Infection sur prothèse dans le premier mois suivant son implantation = urgence médico-chirurgicale
- Prise en charge pluridisciplinaire
  - Au minimum, chirurgien orthopédiste, médecin infectiologue et microbiologiste.
- Nécessité du repérage précoce de l'infection
- Informer patient et entourage des signes d'alerte:
  - Incidents cicatriciels (persistance ou apparition d'une inflammation locale
  - Absence et retard de cicatrisation, désunion, nécrose
  - Ecoulement (même non purulent)
  - Réapparition ou aggravation de la douleur locale postopératoire
  - Dégradation de la récupération fonctionnelle
  - Epanchement douloureux (pour le genou)
  - Signes généraux (fièvre, frissons).

Messages clés (2)

- Diagnostic clinique évident si écoulement purulent ou abcès.
- En cas de signes cliniques évocateurs ou de doute
  => ponction articulaire et acheminement rapide des prélèvements au laboratoire.
- Traitement chirurgical
  - Synovectomie par arthrotomie
  - Exérèse de tous les tissus macroscopiquement infectés + prélèvements microbiologiques multiples
  - Changement de l'implant en un temps si nécessaire

Messages clés (3)

- Traitement médical
  - Antibiothérapie probabiliste secondairement adaptée au micro-organisme identifié soit dans le liquide de ponction articulaire si celle-ci a été réalisée, soit dans les prélèvements peropératoires.
  - Prescrit par (sous le contrôle d') un infectiologue
  - Eventuellement aidé d'un avis auprès d'un centre spécialisé. Tout critère de complexité devrait conduire à une collaboration avec un centre spécialisé.
- À tout moment, aide (voire prise en charge) possible d'un (dans un) centre spécialisé (CRIOA et centres correspondants).

Signes cliniques

- Les signes cliniques locaux qui ***affirment*** l'infection sur prothèse sont :
  - écoulement purulent ;
  - abcès ;
  - fistule.
- Les signes cliniques locaux suivants sont ***évocateurs*** d'infection sur prothèse même en l'absence de signes généraux (fièvre, frissons) :
  - incidents cicatriciels
  - persistance ou apparition d'une inflammation locale,
  - absence et retard de cicatrisation, désunion, nécrose,
  - tout écoulement non purulent ;
  - réapparition ou aggravation de la douleur locale postopératoire ;
  - dégradation de la récupération fonctionnelle ;
  - épanchement douloureux (pour le genou).
- L'existence de signes généraux (fièvre, frissons) est évocatrice d'infection surtout si associée à des signes locaux.

Examens complémentaires

- Il n’est pas recommandé d’effectuer la mesure de la VS, ni de doser la procalcitonine, pour le diagnostic de l’infection sur prothèse dans le premier mois postopératoire.
- Aucun examen d’imagerie n’est nécessaire pour le diagnostic d’infection précoce.
- Seule l’échographie peut être utile pour guider une ponction au niveau de la hanche.

Diagnostic microbiologique (1)

- Il est recommandé de ne pas réaliser de prélèvement superficiel.
  - Si le prélèvement superficiel a déjà été réalisé, il ne faut pas tenir compte de son résultat pour le diagnostic et le traitement.
- Il est recommandé de réaliser des hémocultures.
- Indication de la ponction pré-opératoire uniquement si :
  - un traitement antibiotique probabiliste doit être instauré en urgence avant l'intervention.
  - doute diagnostique

Diagnostic microbiologique (2)

- Il est nécessaire d'informer le laboratoire et de traiter sans délai les prélèvements au laboratoire
- En cas de difficulté d'acheminement (supérieur à 2 h), il est recommandé d'ensemencer directement une partie du liquide articulaire sur flacons d'hémoculture
- L'analyse cytologique (recherche de polynucléaires neutrophiles altérés et de microcristaux) doit être systématique

Information du patient

- Il est recommandé d'informer le patient et/ou la personne de confiance du diagnostic, des bénéfices et des risques de la prise en charge thérapeutique.
- Une aide d'un psychologue peut être envisagée et organisée par l'équipe médico-chirurgicale prenant en charge le patient.
- Les conséquences socioprofessionnelles de l'infection doivent être appréhendées.
- La traçabilité de l'information donnée au patient devra être réalisée dans le dossier médical.

Traitement chirurgical (1)

- La chirurgie arthroscopique n’est pas recommandée
- Il est recommandé de réaliser une synovectomie complète par arthrotomie
  - reprise au minimum la voie d’abord initiale et emportant tous les tissus macroscopiquement infectés.
  - Il est indispensable de luxer la prothèse et de changer les composants « d’interface » de la prothèse
- La découverte d’une mobilité à la jonction os-implant impose le changement de l’implant.
- Le changement de prothèse en un temps doit être envisagé et discuté préalablement avec le patient surtout en cas de prothèse sans ciment.

Traitement chirurgical (2)

- Le changement en deux temps n’a pas sa place sauf situation exceptionnelle estimée par l’équipe médico-chirurgicale et qui devra tenir compte :
  - de l’importance de l’atteinte locale constatée en peropératoire
  - de la complexité microbiologique éventuelle
  - des difficultés thérapeutiques (médicales, anesthésiques et chirurgicales)
  - du retentissement local et général

Traitement chirurgical (3)

- En cas de réimplantation d’une prothèse *cimentée*, il est recommandé d’utiliser du ciment industriel aux antibiotiques.
- Si des drains de Redon ont été mis en place, la culture du liquide de drainage est utile. La positivité des cultures du liquide de drainage justifie une réévaluation médico-chirurgicale et la prise de contact avec un centre spécialisé (CRIOA ou centre correspondant).

Traitement médical (1) Antibioprophylaxie

- Antibioprophylaxie (pour éviter une infection à un nouveau germe) : pas de consensus sur l'indication, ni sur les modalités.

Traitement médical (2) Antibiothérapie probabiliste

- Après prélèvements peropératoires :
  - Vancomycine + [pipéracilline-tazobactam OU céphalosporine de 3e génération (ceftriaxone ou cefotaxime)]
  - Il est recommandé de rajouter un aminoside si sepsis sévère ou choc septique*

*cf. diaporama SPILF utilisation des aminosides

Traitement médical (3) Antibiothérapie documentée

	Traitement initial	Relais oral exclusif
Staphylocoques multisensibles		
Poids ≤ 70 kg	Oxacilline ou Cloxacilline IV, 1,5 g/4H OU Céfazoline IV, 1g/6H	Ofloxacine, 200m g X 2/j ET Rifampicine, 900 mg, une fois/j
Poids >_70 kg	Oxacilline ou Cloxacilline IV, 2 g/4H OU Céfazoline IV, 2g/8H	Ofloxacine, 200m g X 3/j ET Rifampicine, 600 mg x 2/j
Entérobactéries sensibles		
Poids ≤ 70 kg	Cefotaxime IV, 2g/8H OU Ceftriaxone IV, 2g/24H	Ofloxacine, 200m g X 2/j OU Ciprofloxacine, 500 mg X 2/j
Poids > 70 kg	Cefotaxime IV, 9 à 12 g/j en 3 à 6 fois OU Ceftriaxone IV, 1,5 à 2 g/12H	Ofloxacine, 200m g X 3/j OU Ciprofloxacine, 750 mg X 2/j
Streptocoques (mais pas entérocoques)		
Poids ≤ 70 kg	Amoxicilline IV, 1,5 g/4H OU Ceftriaxone IV, 2g/24H	Clindamycine 600 mg X 3/j OU Amoxicilline 2 g X 3/j
Poids >_70 kg	Amoxicilline IV, 2 g/4H OU Ceftriaxone IV, 1,5 à 2 g/12H	Clindamycine 600 mg X 4/j OU Amoxicilline 3 g X 3/j

Traitement médical (4)

- La durée optimale de l'antibiothérapie intraveineuse (initiale) n'ayant pas été évaluée dans la littérature, celle-ci est comprise entre 5 jours et 6 semaines en fonction des micro-organismes retrouvés et du terrain.
- Des hémocultures positives nécessiteraient une antibiothérapie IV d'au moins 7 jours.
- Il est recommandé de réévaluer l'antibiothérapie entre les 48e et 72e heures de la prescription

Traitement médical (5)

- L’infectiologue décide si un avis doit être demandé à un centre spécialisé (CRIOA ou centre correspondant) pour les cas particuliers
  - allergie ou intolérance aux antibiotiques
  - résistances bactériennes
  - infection polymicrobienne
  - pathogène non abordé dans cette recommandation
  - tout autre problème lié au terrain (obésité morbide) ou aux conditions de prise en charge

Durée de traitement et suivi

- Il est recommandé de traiter entre 6 semaines et 3 mois
- Il n’est pas recommandé de prolonger le traitement au-delà de 3 mois
- La surveillance biologique hebdomadaire de la CRP a un intérêt dans la phase précoce du traitement